

---

QCM · CONCOURS

---

# Concours-Radiologie-CHU-Tanger-Tetouan

---

52 questions

## Questions

7 L'orthopantomographie :

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| A | Est réalisée en position debout ou assise                     |
| B | Incidence impossible à réaliser en décubitus                  |
| C | La mandibule repose sur un étrier où elle est calée           |
| D | La contention peut comporter un guide buccal et un serre-tête |

8 Profil d'Arcelin :

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| A | Est une incidence de profil chirurgical de la hanche                           |
| B | Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en flexion              |
| C | La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur cuisse |
| D | La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté à radiographier        |

9 Critères de réussite d'une incidence oblique du rachis cervical :

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| A | Bon dégagement des trous de conjugaison à tous les niveaux |
| B | Superposition des apophyses articulaires droite et gauche  |
| C | Dégagement de toutes les interlignes articulaires          |
| D | Bonne visualisation des pédicules du côté examiné          |

10 Les critères de réussite d'une radiographie du bassin de face :

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| A | Superposition de l'axe du sacrum et de la symphyse pubienne     |
| B | Dégagement externe complet du grand trochanter                  |
| C | Petit trochanter coupé par la corticale de la diaphyse fémorale |
| D | Trous obturateurs symétriques                                   |

**11** Radiographie du rachis cervical « bouche ouverte » :

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Incidence de face antéro-postérieure                      |
| <b>B</b> | Permet la visualisation du processus odontoïde et l'atlas |
| <b>C</b> | Rayon directeur est horizontal                            |
| <b>D</b> | Réalisée en décubitus en cas de traumatisme important     |

**12** Incidence de Lamy :

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Incidence de profil de l'épaule                                                             |
| <b>B</b> | Réalisée chez un sujet en position debout en oblique antérieure de 45 à 60° du côté examiné |
| <b>C</b> | Le bras est pendant, coude fléchi et légèrement porté en arrière                            |
| <b>D</b> | Rayon directeur est horizontal                                                              |

**13** Radiographie de face de la clavicule :

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Rayon directeur est postéro-antérieur                                       |
| <b>B</b> | Rayon directeur est horizontal                                              |
| <b>C</b> | Visualisation de la clavicule dans sa totalité                              |
| <b>D</b> | Visualisation des articulations acromio-claviculaire et sterno-claviculaire |

**28** Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr :

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie                                                   |
| <b>B</b> | Le Cliché sans préparation est obligatoire et permet de recherche des calcifications au niveau de l'hypochondre droit |
| <b>C</b> | L'injection du produit de contraste est suivie en scopie                                                              |
| <b>D</b> | L'injection du produit de contraste est rapide                                                                        |

29 Un uroscanner :

- A Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale
- B Est indiqué devant une obstruction urinaire
- C Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires
- D Est contre-indiquée en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l

30 En cas d'insuffisance rénale aiguë :

- A L'injection du produit de contraste iodé est contre-indiquée
- B Une hypohydratation avant et après l'injection de produit de contraste iodé doit être réalisée
- C Les médicaments néphrotoxiques doivent être arrêtés pendant au moins 48 heures
- D Un intervalle d'au moins 3 jours entre deux injections de produit de contraste iodé s'impose

31 La vaccination au Maroc commence :

- A immédiatement après la naissance
- B A une semaine de la naissance
- C A six semaines de la naissance
- D A dix semaines de la naissance

32 Le programme de vaccination au Maroc vise à prévenir les maladies suivantes :

- A L'hépatite virale C
- B L'hépatite virale B
- C La rubéole
- D La varicelle

**33** La prophylaxie correspond aux :

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Mesures entreprises pour traiter les cas                                           |
| <b>B</b> | Mesures entreprises pour éviter la survenue de la maladie                          |
| <b>C</b> | Mesures entreprises pour éviter la contagion de la maladie                         |
| <b>D</b> | Actions entreprises pour la prise en charge psychologique de l'entourage du malade |

**34** L'indice synthétique de fécondité au Maroc en 2013 est de :

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>A</b> | Un enfant par femme      |
| <b>B</b> | Deux enfants par femme   |
| <b>C</b> | Trois enfants par femme  |
| <b>D</b> | Quatre enfants par femme |

**23** Radiographie de face de la clavicule :

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Rayon directeur est postéro-antérieur                                       |
| <b>B</b> | Rayon directeur est horizontal                                              |
| <b>C</b> | Visualisation de la clavicule dans sa totalité                              |
| <b>D</b> | Visualisation des articulations acromio-claviculaire et sterno-claviculaire |

**24** Radiographie du coude de face :

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Patient assis, membre supérieur en extension sur la table et main en supination |
| <b>B</b> | Rayon directeur est vertical                                                    |
| <b>C</b> | Centrage au milieu du pli du coude                                              |
| <b>D</b> | Centrage au bord postérieur de l'épicondyle                                     |

25 Incidence de Schreck II :

- A Réalisée sur main fléchie en position d'écriture et en demi-supination à 25°
- B Rayon directeur est vertical
- C Centrage à 1cm en avant de l'interligne radio-carpienne
- D Incidence permettant l'analyse du scaphoïde

26 Incidence de profil chirurgical de la hanche :

- A Profil d'Arcelin
- B Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en extension
- C La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur la cuisse
- D La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté opposé

27 La prémédication avant un examen avec injection de produit de contraste iodé :

- A Doit être utilisé pour rassurer le patient
- B N'empêche pas la survenue d'une anaphylaxie
- C Est remplacée actuellement par la consultation d'allergologie
- D Est systématique pour les patients aux antécédents d'anaphylaxie pour un certain produit de contraste

28 Urographie intra-veineuse :

- A Contre-indiquée chez la femme enceinte
- B Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices
- C Est actuellement supplantée par l'uroscanner
- D Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral passif et actif

**29** La Fibrose Néphrogénique Systémique :

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Atteinte cutanée puis systémique des articulations, du coeur et des poumons                   |
| <b>B</b> | Peut-être responsable du décès du patient                                                     |
| <b>C</b> | Secondaire à l'injection de chélates de gadolinium lors d'examen IRM                          |
| <b>D</b> | Survient chez des patients insuffisants rénaux avec une clairance de la créatinine > 30ml/min |

**20** En mammographie, le rayonnement diffusé :

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Entraîne un noircissement du film sans apporter plus d'informations |
| <b>B</b> | Diminue la fiabilité diagnostique                                   |
| <b>C</b> | L'utilisation de clichés centrés simples augmente ce rayonnement    |
| <b>D</b> | Est plus important dans les seins très denses                       |

**21** En mammographie, la compression du sein :

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Est indispensable pour diminuer le contraste          |
| <b>B</b> | Est relativement facile en cas de tissu mammaire sain |
| <b>C</b> | Augmente de façon sensible la dose d'irradiation      |
| <b>D</b> | Réduit de façon sensible le rayonnement diffusé       |

**22** Les critères de qualité d'un cliché oblique externe en mammographie :

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Muscle pectoral doit être visible jusqu'à hauteur du mamelon                      |
| <b>B</b> | Le muscle pectoral doit faire avec le bord latéral du film un angle d'environ 45° |
| <b>C</b> | Le sillon sous-mammaire doit être visible sur le cliché                           |
| <b>D</b> | Le tissu glandulaire doit être bien étalé                                         |

23 L'Hystérosalpingographie :

|   |                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Est indiquée en cas d'infection génitale                                                                                       |
| B | Est indiquée en cas d'infertilité secondaire                                                                                   |
| C | Une couverture antibiotique est systématique                                                                                   |
| D | Est réalisée en deuxième partie de cycle permet afin d'éviter une dissection de l'endomètre lors de l'introduction du cathéter |

24 En IRM, la pondération T2 se caractérise par :

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| A | Un temps d'écho est $> 80$ ms              |
| B | Un temps de répétition $> 2000$ ms         |
| C | Un temps d'écho est $> 20$ ms              |
| D | Un hypersignal des structures liquidiennes |

25 En IRM, les antennes en réseau phasé :

|   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées côte à côte |
| B | Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées face à face |
| C | Permettent un très bas signal sur bruit                                                           |
| D | Permettent un petit champ d'exploration                                                           |

31 Les services déconcentrés du Ministère de la Santé sont représentés par :

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| A | Les directions régionales de santé    |
| B | Les directions centrales              |
| C | Les CHU                               |
| D | Les délégations provinciales de santé |



32 Laquelle des directions suivantes ne fait pas partie du ministère de la Santé :

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| A | Direction de la population                    |
| B | Direction des médicaments et de pharmacie     |
| C | Direction de santé publique                   |
| D | Direction de réglementation et de contentieux |

33 Une Direction Régionale de santé est composée de :

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | 5 unités régionales |
| B | 6 unités régionales |
| C | 7 unités régionales |
| D | 3 à 4 services      |

34 Le réseau de soins de santé de base comporte :

|   |                          |
|---|--------------------------|
| A | Centre de santé communal |
| B | Centre de santé urbain   |
| C | Hôpital local            |
| D | Dispensaires rural       |

35 Lequel des établissements suivant ne sont pas généralement médicalisés :

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| A | Dispensaire rural                                  |
| B | Centre de santé communal                           |
| C | Centre de santé urbain                             |
| D | Centre de santé communal avec unité d'accouchement |

**36** Un hôpital régi en mode d'établissement public autonome est un hôpital :

- A** Qui a une autonomie administrative et n'a pas d'autonomie financière
- B** Qui a une autonomie financière et n'a pas d'autonomie administrative
- C** Qui n'a ni autonomie administrative ni autonomie financière
- D** Qui a une autonomie administrative et une autonomie financière

**7** Incidence des os propres du nez :

- A** Incidence antéro-postérieure
- B** Centrage à la base du nez
- C** L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de  $-30^\circ$
- D** L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de  $-70^\circ$

**8** Incidence Blondeau :

- A** Incidence qui permet d'analyser les sinus de la face
- B** L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de  $-50^\circ$
- C** Nez est à 1cm de la plaque
- D** Equidistance des conduits auditifs externes par rapport à la cassette

**9** Radiographie (obliques) du rachis cervical :

- A** Patient en position debout ou assis en oblique postérieure du côté examiné
- B** L'angle d'obliquité est de  $45^\circ$  à  $60^\circ$
- C** Rayon directeur est ascendant de  $20^\circ$
- D** Centrage sur la face latérale du cou, à hauteur de C2

**10** Radiographie des sacro-iliaques :

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Réalisée en décubitus avec membres inférieurs légèrement fléchis                             |
| <b>B</b> | Rayon directeur incliné vers la tête de 15 à 20°                                             |
| <b>C</b> | Centrage à deux travers de doigt au-dessous du bord supérieur du pubis, sur la ligne médiane |
| <b>D</b> | Incidence antéro-postérieure                                                                 |

**11** Incidence de Chevrot :

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Incidence oblique, visualisant l'articulation sacro-iliaque dans le plan horizontal           |
| <b>B</b> | Patient en décubitus, tronc fléchi en appui sur les coudes et membres inférieurs en extension |
| <b>C</b> | Bassin soulevé de 20° du côté à radiographier grâce à une cale en mousse                      |
| <b>D</b> | Rayon directeur est incliné de 30 à 50° vers les pieds                                        |

**12** Incidence de Lamy :

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Incidence permettant l'exploration de la ceinture scapulaire     |
| <b>B</b> | Patient debout en oblique antérieure de 45 à 60° du côté opposé  |
| <b>C</b> | Le bras est pendant, coude fléchi et légèrement porté en arrière |
| <b>D</b> | Rayon directeur est horizontal                                   |

**13** Les critères de réussite d'une incidence de Neer :

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>A</b> | L'omoplate se présente sous la forme d'un « Y » |
| <b>B</b> | L'écaille est vue de face                       |
| <b>C</b> | L'articulation gléno-humérale bien dégagée      |
| <b>D</b> | Articulation acromio-claviculaire est visible   |

**14** Radiographie du coude de profil :

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Patient assis, coude fléchi à 45° reposant sur la plaque par son bord interne, main verticale |
| <b>B</b> | Rayon directeur est vertical                                                                  |
| <b>C</b> | Centrage au bord postérieur de l'épicondyle                                                   |
| <b>D</b> | Centrage au bord postérieur de la trochlée                                                    |

**15** Incidence de Schreck II :

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Réalisée sur main fléchie en position d'écriture et en demi-supination à 25° |
| <b>B</b> | Rayon directeur est vertical                                                 |
| <b>C</b> | Centrage à 1cm en avant de l'interligne radio-carpienne                      |
| <b>D</b> | Incidence permettant l'analyse du scaphoïde                                  |

**16** Incidence de profil chirurgical de la hanche :

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Profil d'Arcelin                                                                  |
| <b>B</b> | Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en extension               |
| <b>C</b> | La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur la cuisse |
| <b>D</b> | La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté opposé                    |

**17** Urographie intra-veineuse :

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Peut être indiquée devant un syndrome obstructif urinaire               |
| <b>B</b> | Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices |
| <b>C</b> | Est actuellement supplantée par l'uroscanner                            |
| <b>D</b> | Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif                    |

**18** Urétrocystographie rétrograde :

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | L'injection du produit de contraste est réalisée par voie intra-veineuse |
| <b>B</b> | Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif lors du remplissage |
| <b>C</b> | Un cliché post-mictionnel est indispensable                              |
| <b>D</b> | Est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale                         |

**19** L'incidence qui permet d'étudier l'apophyse zygomatique est :

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | Incidence de HIRTZ SUBAXIALE          |
| <b>B</b> | Worms-Bretton (incidence semi-axiale) |
| <b>C</b> | Incidence de crâne de face            |
| <b>D</b> | Incidence de crâne de profil          |

**1** Incidence de crâne de face haute est :

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Une incidence antéro-postérieure                                                                           |
| <b>B</b> | Réalisée chez un sujet assis avec un appui front-nez                                                       |
| <b>C</b> | Réalisée chez un sujet assis avec un appui sur le front                                                    |
| <b>D</b> | Centrage est basé sur l'équidistance des deux conduits auditifs externes par rapport au plan de projection |

**2** Les critères de réussite d'une incidence de crâne de face haute sont :

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Fentes sphénoïdales dans les orbites                                                                      |
| <b>B</b> | Bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs                             |
| <b>C</b> | Distance apophyse orbitaire du malaire et table interne de la voûte latérale est identique des deux côtés |
| <b>D</b> | Distance apophyse orbitaire du malaire et table externe de la voûte latérale est identique des deux côtés |

3 Incidence de crâne de profil :

- A L'angle formé entre le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de  $15^\circ$
- B Rayon directeur est horizontal
- C Le centrage est à 3cm au-dessus du tragus
- D Le centrage est à 3cm au-dessus du tragus

4 Les critères de réussite d'une incidence de crâne de profil :

- A Superposition droite-gauche des planchers orbitaires
- B Superposition des grandes ailes du sphénoïde
- C Superposition des conduits auditifs externes
- D Superposition des apophyses clinoides

5 Incidence de HIRTZ :

- A Le centrage est au niveau de la ligne bi-oculaire
- B Indiquée en cas de traumatisme du rachis cervical
- C L'angle formé par le rayon directeur et le plan sagittal médian est de  $0^\circ$
- D L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de  $-150^\circ$

6 Incidence de Worms-Bretton (incidence semi-axiale) :

- A Le plan orbito-méatal oblique au plan de projection
- B Equidistance des deux conduits auditifs externes à la cassette
- C Les rochers sont situés largement au-dessus des rebords orbitaires supérieurs
- D L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de  $25^\circ$

## Notes d'extraction

- Duplicate question number: 28
- Duplicate question number: 29
- Duplicate question number: 23

- Duplicate question number: 24
- Duplicate question number: 25
- Duplicate question number: 31
- Duplicate question number: 32
- Duplicate question number: 33
- Duplicate question number: 34
- Duplicate question number: 7
- Duplicate question number: 8
- Duplicate question number: 9
- Duplicate question number: 10
- Duplicate question number: 11
- Duplicate question number: 12
- Duplicate question number: 13